

EPILEPSIA	CARACTERÍSTICAS
Generalizada con ausencias de pequeño mal	• Más frecuente en niños de 6-8 años • Crisis diurnas frecuentes • Etiología: elevada predisposición genética
Síndrome de West (epilepsia del lactante)	• Aparición frecuente durante el 4º-6º mes de vida • Etiología: criptogénico o sintomático (encefalopatía, malformación cerebral o meningoencefalitis) • Clínica: espasmos mioclónicos masivos, EEG hipsarrítmico y deterioro psicomotor y mental. • Pronóstico: desfavorable con tendencia al deterioro • Suele ser farmacorresistente
Síndrome de Lennox-Gastaut	• Inicio: 2 - 8 años. • Crisis epilépticas polimorfas: atónicas, tónicas, ausencias y estatus epiléptico. • Discapacidad intelectual con deterioro progresivo en el 90% de los casos. • Encefalopatía asociada al cuadro. • Pronóstico: desfavorable, el 80% sigue presentando crisis a pesar del tratamiento.
Benigna infantil (epilepsia rolándica)	• Inicio: antes de los 10 años • La modalidad de epilepsia parcial más frecuente en la niñez. • Etiología: carácter autonómico dominante. Antecedentes familiares. • Las crisis se presentan durante el sueño o el despertar. • El CI suele ser normal y sin alteraciones • Pronóstico: tiende a desaparecer durante la adolescencia • Descargas fronto-temporales y síntomas orofaríngeos (sonidos guturales).
Benigna infantil con paroxismos occipitales	• Características similares a la epilepsia rolándica. • Crisis en forma de alucinaciones visuales, acompañadas de manifestaciones motoras y migrañas. • Pronóstico: peor que la epilepsia rolándica.
Mioclónica juvenil	• Inicio: 12-18 años • Clínica: crisis mioclónicas en extremidades superiores y crisis tónico-clónicas.

(epilepsia del adolescente)	• Déficits: planificación, control e inhibición de la conducta, razonamiento lógico y memoria de trabajo. • Pronóstico: favorable, frecuente desaparición • Detonantes: alcohol, foto estimulación, estrés y la privación de sueño
Benigna psicomotora	• Modalidad de epilepsia idiopática, parcial y benigna de la infancia. • Síntomas afectivos, predominando miedo o terror. • Se acompaña de otros automatismos: masticación, deglución, risa, palidez o sudoración. • Pronóstico: muy favorable.